

Enfermedad arterial periférica (EAP)

1. Introducción y relevancia clínica

La **enfermedad arterial periférica (EAP)** es la manifestación **extracoronaria de la aterosclerosis sistémica**, caracterizada por el **estrechamiento progresivo de las arterias** de las extremidades, principalmente las inferiores.

Su importancia radica en que:

- Es un **marcador de enfermedad cardiovascular sistémica** (asociada a infarto y ACV).
- Afecta a **10–20% de los adultos mayores de 60 años**.
- En Chile, su prevalencia está en aumento por la alta incidencia de **diabetes, hipertensión y tabaquismo**.

Relevancia clínica

- Su detección precoz permite **prevenir amputaciones** y reducir eventos cardiovasculares mayores.
 - Es una de las causas más frecuentes de **claudicación intermitente y úlceras crónicas de extremidades inferiores**.
 - El **diagnóstico clínico y doppler** es evaluado directamente en EUNACOM (física y teórica).
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo fisiopatológico

La **aterosclerosis** es el proceso subyacente:

1. Acúmulo de LDL oxidada en el endotelio arterial.
2. Infiltración de macrófagos → formación de células espumosas.

3. Placa ateromatosa → engrosamiento, estenosis y trombosis arterial.
 4. Disminución del flujo sanguíneo distal → isquemia tisular.
-

2.2 Localización más frecuente

- Arterias **iliofemorales**.
 - Arterias **poplíteas**.
 - Arterias **tibiales** (en diabéticos).
-

2.3 Factores de riesgo

Modificables	No modificables
Tabaquismo ☐ (principal)	Edad avanzada
Diabetes mellitus	Sexo masculino
Hipertensión arterial	Historia familiar de aterosclerosis
Dislipidemia (↑ LDL, ↓ HDL)	Raza (mayor riesgo en afrodescendientes)
Sedentarismo, obesidad	—
☐ El tabaquismo aumenta el riesgo relativo hasta 4 veces.	
☐ La diabetes mellitus multiplica por 3 el riesgo y acelera la progresión distal.	

2.4 Tipos de presentación clínica

Tipo	Descripción
EAP crónica	Aterosclerosis progresiva (claudicación, isquemia crónica).
EAP aguda (isquemia aguda)	Oclusión súbita por trombo o émbolo (ver tema 33).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas principales

Síntoma	Descripción
Claudicación intermitente	Dolor o calambre muscular al caminar, aliviado con el reposo. Sitio depende del nivel de obstrucción: - Glúteo → aortoiliaca - Muslo → femoral superficial - Pantorrilla → poplítea
Dolor en reposo	Indica isquemia crítica, usualmente nocturna o al elevar la pierna.
Frialdad y palidez distal	Por hipoperfusión.
Úlceras o necrosis	Isquemia tisular avanzada.

3.2 Examen físico

Hallazgo	Significado
----------	-------------

Disminución o ausencia de pulsos periféricos	Estenosis u oclusión arterial
--	-------------------------------

Soplo femoral o poplíteo	Turbulencia del flujo arterial
--------------------------	--------------------------------

Palidez al elevar el miembro	Compromiso perfusional
------------------------------	------------------------

Eritema en declive (rubor dependiente)	Vasodilatación compensatoria
--	------------------------------

Piel atrófica, pérdida de vello, uñas engrosadas	Isquemia crónica
--	------------------

☐ **Clásico signo de Buerger:** palidez al elevar el pie → rubor reactivo al bajarlo.

3.3 Clasificación de Rutherford (grados de EAP crónica)

Grado	Manifestación clínica
-------	-----------------------

0	Asintomático
---	--------------

1	Claudicación leve
---	-------------------

2	Claudicación moderada
---	-----------------------

3	Claudicación severa
---	---------------------

4	Dolor en reposo
---	-----------------

- 5 Úlcera isquémica
 pequeña
- 6 Gangrena extensa

3.4 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias
Claudicación neurogénica (estenosis lumbar)	Dolor no relacionado con ejercicio, mejora al sentarse o inclinarse
Trombosis venosa profunda	Miembro caliente, edematoso
Artritis / artrosis	Dolor articular, no muscular
Neuropatía diabética	Parestesias, sin cambios de color ni pulsos disminuidos

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Índice Tobillo–Brazo (ITB)

Prueba simple y costo-efectiva.

| ITB = (Presión sistólica tobillo) / (Presión sistólica braquial más alta) |

Valor	Interpretación
-------	----------------

1.0 – 1.4 Normal

0.9 – 0.7 EAP leve

0.69 – 0.4 EAP moderada

<0.4 EAP severa / isquemia
 crítica

En diabéticos, arterias calcificadas pueden dar falsos valores altos → usar índice dedo–brazo o doppler segmentario.

4.2 Ecografía Doppler arterial

- Mide velocidad del flujo y localiza estenosis.
 - Método diagnóstico inicial en atención secundaria.
 - Sensibilidad >90% para lesiones hemodinámicamente significativas.
-

4.3 AngioTAC o AngioRM

- Mapa anatómico preciso previo a cirugía o angioplastia.
 - Determina extensión y localización de la oclusión.
-

4.4 Arteriografía convencional

- Gold standard para planificación quirúrgica o endovascular.
 - Permite tratamiento simultáneo (angioplastia, stent).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL, AHA y ESC 2023)

5.1 Medidas generales

1. **Suspensión absoluta del tabaco.**
2. Control estricto de:
 - HTA (meta <130/80 mmHg).
 - Diabetes (HbA1c <7%).
 - Dislipidemia (LDL <70 mg/dL).
3. Ejercicio supervisado: caminar 30–45 min, 3–5 veces por semana.
4. Cuidados locales del pie (en diabéticos).

5.2 Tratamiento médico

Grupo farmacológico	Ejemplo	Objetivo
Antiagregante plaquetario	Aspirina 75–325 mg/día o Clopidogrel 75 mg/día	Prevención trombótica
Estatinas	Atorvastatina 40–80 mg/día	Reducción de eventos CV y estabilización de placa
Vasodilatadores / antiisquémicos	Cilostazol 100 mg/12 h	Mejora distancia de claudicación (excepto en IC)
Anticoagulación	NOACs o Warfarina en casos seleccionados	En trombosis asociada o postrevascularización

El **Cilostazol** está aprobado en Chile para pacientes con claudicación que no son candidatos quirúrgicos.

5.3 Tratamiento endovascular (mínimamente invasivo)

- **Indicaciones:**
 - Claudicación incapacitante pese a tratamiento médico.
 - Isquemia crítica (dolor en reposo o úlceras).
- **Técnicas:**
 - Angioplastia con balón ± stent.
 - Aterectomía (remoción de placa).
 - Tromboaspiración (en casos agudos).

Tasa de éxito: 80–90% en lesiones cortas (<5 cm).

5.4 Cirugía abierta (bypass arterial)

- **Indicaciones:**
 - Oclusión extensa o fracaso de endovascular.
 - Isquemia crítica con úlcera o gangrena.
- **Tipos de bypass:**
 - **Aorto-femoral** (para lesiones ilíacas).
 - **Fémoro-poplíteo** (vena safena autóloga = gold standard).
 - **Distal o tibial** (en diabéticos).

La **revascularización quirúrgica** mejora la supervivencia de la extremidad y la calidad de vida.

5.5 Manejo de la isquemia crítica

(Ver relación con tema 33: Isquemia aguda de extremidades)

- Dolor en reposo, úlceras o necrosis.

- Requiere hospitalización y manejo urgente:
 - Analgesia, heparina, antibióticos si infección.
 - Evaluar revascularización urgente.
 - Amputación si tejido no viable.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Úlceras isquémicas crónicas	En pies o dedos, dolorosas, de bordes definidos
Gangrena	Necrosis tisular irreversible
Amputación	Última opción en isquemia crítica
Trombosis de injerto	Postbypass o postangioplastia
Infección local o sepsis	Por ulceración prolongada

Pronóstico:

- Mortalidad global a 5 años $\approx$ 30–50%.
 - 25% requerirá amputación si no se revasculariza.
 - 50% morirá por evento cardiovascular (IAM o ACV).
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Claudicación intermitente + ITB $<0,9$ = diagnóstico de EAP.**
 2. **Dolor en reposo o úlceras = isquemia crítica (Rutherford 4–6).**
 3. **Doppler arterial** es el examen inicial más costo-efectivo.
 4. **Suspender tabaco** es la intervención más costo-efectiva.
 5. **Cilostazol** mejora la claudicación (no usar en IC).
 6. **Bypass con vena safena** = gold standard para lesiones femoropoplíteas.
 7. **Evaluar función cardíaca y renal antes de cirugía.**
-



Errores comunes

- Confundir claudicación vascular con claudicación neurogénica.
 - No medir el ITB en pacientes diabéticos o fumadores con dolor en piernas.
 - Indicar angiografía sin Doppler previo.
 - No corregir factores de riesgo antes de la cirugía.
 - Retardar la revascularización en isquemia crítica.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **La EAP es la manifestación periférica de la aterosclerosis sistémica.**
2. **Síntoma cardinal:** claudicación intermitente, diagnosticada con **ITB $<0,9$.**
3. **Tratamiento médico:** antiagregantes, estatinas, control de factores de riesgo y ejercicio.

4. **Cilostazol** es útil para aumentar la distancia de claudicación.
5. **Revascularización (endovascular o quirúrgica)** en casos severos o isquemia crítica.
6. **El tabaquismo y la diabetes** son los factores pronósticos más determinantes.
7. **Prevención cardiovascular global** es esencial para mejorar la supervivencia.